



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT JALAN

TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Pengorganisasian
Instalasi Rawat Jalan Tahun 2025 Disusun oleh:

Kepala Instalasi Rawat Jalan



(dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHt., CI., CHAE., CHQP)

Ditetapkan oleh:

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CCHt., Cl., CHAE., CHQP

PENYUSUN

1. dr. Riski Bagus Suhendra, Sp.DVE
2. dr. Santoso Rahardjo, Sp. OG
3. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG
4. dr. Agung Wijaya Kusuma Sp. OG
5. dr. Muhammad Irawan, Sp.A
6. dr. Esti Purwaningrum, Sp.A
7. dr. Ratih Kusumawardani, Sp.A, M.Biomed
8. dr. Qashastia Sukma Paripurna Sp.A
9. dr. Cameleia Diah Setyorini, Sp.PD
10. dr. Heriyatmo, Sp.PD
11. dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD
12. dr. Aditya Purwaka, Sp.PD
13. dr. Adhya Aji Pratama, Sp.PD
14. dr. Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.PD-KGH
15. dr. Angga Prawira Purwanto, Sp.B
16. dr. Zaki Yamani, Sp.B
17. dr. Djanuar Fitriadi, Sp.B
18. dr. Arianto Prabowo, Sp.OT
19. dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT
20. dr. Fiski Purantoro, Sp.OT
21. dr. Fendi Fatkhurrohman Gozi, Sp.BS
22. dr. Ahmad Farid Wajdi, Sp.N
23. dr. Aan Dwi Prasetyo, Sp.N
24. dr. Akhmad Zainul Arifin, Sp.N., M.Kes
25. dr. Rachmawati Wardani Sp.N
26. dr. Badariyatud Dini, Sp.BP-RE(K)
27. drg. Syafrini Farrahdebi
28. dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U
29. dr. Novita Maulidiyah, Sp.P
30. dr. Fitri Indahyanti, Sp.P., MMRS
31. dr. Kristia Fahmi, Sp.P
32. dr. Maria Valentina Evelyn, Sp.JP
33. dr. Dion Setiawan Sp.JP
34. dr. Nurhadhi Sutanto, Sp.M
35. dr. N. Indra Bayu, Sp.M
36. dr. Latifah, Sp.M
37. dr. Julian Hertawan, Sp.T.H.T.K.L
38. dr. Fuad Fauzi, Sp.T.H.T.K.L
39. dr. Yekti Mumpuni, Sp.KJ
40. dr. Andika Widiyanti, Sp.KJ
41. dr. Erinda Rahma Mulia, Sp.KFR
42. dr. Eko Nugroho, Sp.KFR
43. dr. Tamara Aulia Fakhrinnisa
44. Bagas Surya Purwono Amd.Kep
45. S. Khilmin N., AMd.Kep
46. Selly M. P, AMd. Kep
47. Vira Agustin S, AMd.Kep
48. Irawati, AMd.Kep
49. Ns. Siti Julaihah S.Kep
50. Firdhausi N, AMd.Kep

-
51. Edo Vicky, S.Kep., Ns
 52. Shara Wahyuni, AMd.Kep
 53. Dimas Ragil A, AMd.Kep
 54. Rezza Anggela, S.Kep, Ns
 55. Selvia Leli A, S.Kep, Ns
 56. Aulia Rahmah, AMd.Keb
 57. Novi Lianti R, S.Keb.Bd
 58. Iin Widowati, Str.Keb
 59. Ana Nurul Firdausi, AMd.Kep
 60. Ns. Rita Amalia Karyow, S. Kep
 61. Yuyun Dianita, A.Md.Kep
 62. David Pamungkas Aprilindo, AMd. Kep
 63. Ns. Citra Intan Pratiwi, S.Kep
 64. Ns. Mega Cynthia Rahmawati, S.Tr.Kep
 65. Avita Maulidia, S.Kep., Ns
 66. Muhammad Rofi'ur Rutabi A.Md.Kep.Gi
 67. Ns. Mariatul Qiftiyah, S.Tr.Kep
 68. Istigosah, Amd. Kep
 69. Miati, AMd.Kep

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 836.3/RSPHS/I-PER/DIR/IX/2025
TENTANG**

PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI RAWAT JALAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan yang efektif dan efisien bagi pasien Rawat Jalan di rumah sakit
 - Bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada sebelumnya tentang Pedoman Pengorganisasian Rawat Jalan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruh a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Unit Instalasi Rawat Jalan
- Mengingat :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
 - Peraturna Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jamninan Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 - Peraturan BPJS kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
 - Kepdirjen Nomor HK-02-02-D-47104-2024 tentang Instrument Survei Akreditasi Rumah Sakit
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang standar akreditasi rumah sakit
 - Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43853/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit Kelas D Pratama
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 - Kepkonsil No. 21A Th 2006 ttg Pengesahan Standar Kompetensi Dokter
 - Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 (01 November 2025 hingga 31 Oktober 2026)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI
RAWAT JALAN**

Pasal 1

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Jalan digunakan sebagai acuan dalam Organisasi di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 3548.1/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Rawat Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 01 September 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep, M. kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 836.3/RSPHS/I-PER/DIR/IX/202
TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
INSTALASI RAWAT JALAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal, merata, dan berkesinambungan. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau.

Instalasi Rawat Jalan merupakan salah satu unit pelayanan utama di rumah sakit yang menjadi pintu masuk bagi sebagian besar pasien. Pelayanan rawat jalan berperan dalam memberikan diagnosis dini, pengobatan, serta tindak lanjut perawatan tanpa memerlukan perawatan inap. Selain itu, instalasi ini juga berfungsi sebagai penghubung pelayanan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan pasien dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan berkualitas, Instalasi Rawat Jalan dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien. Hal ini mencakup pengaturan alur pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti rekam medis elektronik sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Selain itu, dalam rangka menjamin mutu dan keselamatan pasien, pelayanan di Instalasi Rawat Jalan harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, termasuk penerapan sasaran keselamatan pasien dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Dengan adanya pedoman pelayanan Instalasi Rawat Jalan, diharapkan seluruh tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang terstandar, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit

1.2. Tujuan

Tujuan Umum :

1. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan rawat jalan yang aman, berkualitas, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien sesuai dengan staf

Tujuan Khusus :

1. Menyeragamkan alur dan proses pelayanan rawat jalan di seluruh unit terkait.
2. Menjamin pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional (SPO), dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit .
3. Meningkatkan pelayanan bersama melalui penerapan indikator saling dan evaluasi berkelanjutan.

-
4. Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah.
 5. Menjamin tertib administrasi dan dokumentasi pelayanan se Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
 6. Membantu pelaksanaan sistem referensi dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
 7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana).
 8. Menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan perbaikan

BAB II
GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

2.1 Deskripsi Rumah Sakit Prima Husada

Rumah Sakit Prima Husada berlokasi di Jalan Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan, Telepon (0343) – 6745000, Email ; sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com. www.rs-primahusada.com

Rumah Sakit Prima Husada adalah salah satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan langsung khususnya pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur dan memiliki 3 Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Umum, dalam tugasnya dibantu oleh para Kepala Instalasi dan Kepala Unit/ Kepala Ruang.

Rumah Sakit Prima Husada menyediakan beberapa pelayanan yang meliputi: pelayanan Instalasi Gawat Darurat 24 Jam, Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari ruang isolasi, Kelas I,II,III dan VIP, Instalasi Kamar Operasi, *Intensive Care Unit*, Hemodialisa, Pelayanan Poli Spesialis yang terdiri dari pelayanan spesialis anak, spesialis bedah, spesialis ortopedi, spesialis mata, spesialis THT, spesialis dermatologi venerologi, spesialis kesehatan jiwa, poli rehab medik, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, spesialis syaraf, spesialis urologi, spesialis bedah plastik, spesialis paru, pelayanan gigi dan mulut. Selain itu juga membuka pelayanan laboratorium dan BDRS dan pelayanan radiologi.

Dalam upaya memberikan pelayanannya, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan sebaik – baiknya sebagai *public service*. Meningkatnya tuntutan dapat dilihat dengan munculnya kritik – kritik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan yang diberikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo perlu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan secara bertahap melalui upaya program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

2.2 Sejarah Institusi Rumah Sakit Prima Husada

Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih luas, maka kamipun berupaya mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, sehingga mengantarkan kami pada berdirinya Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

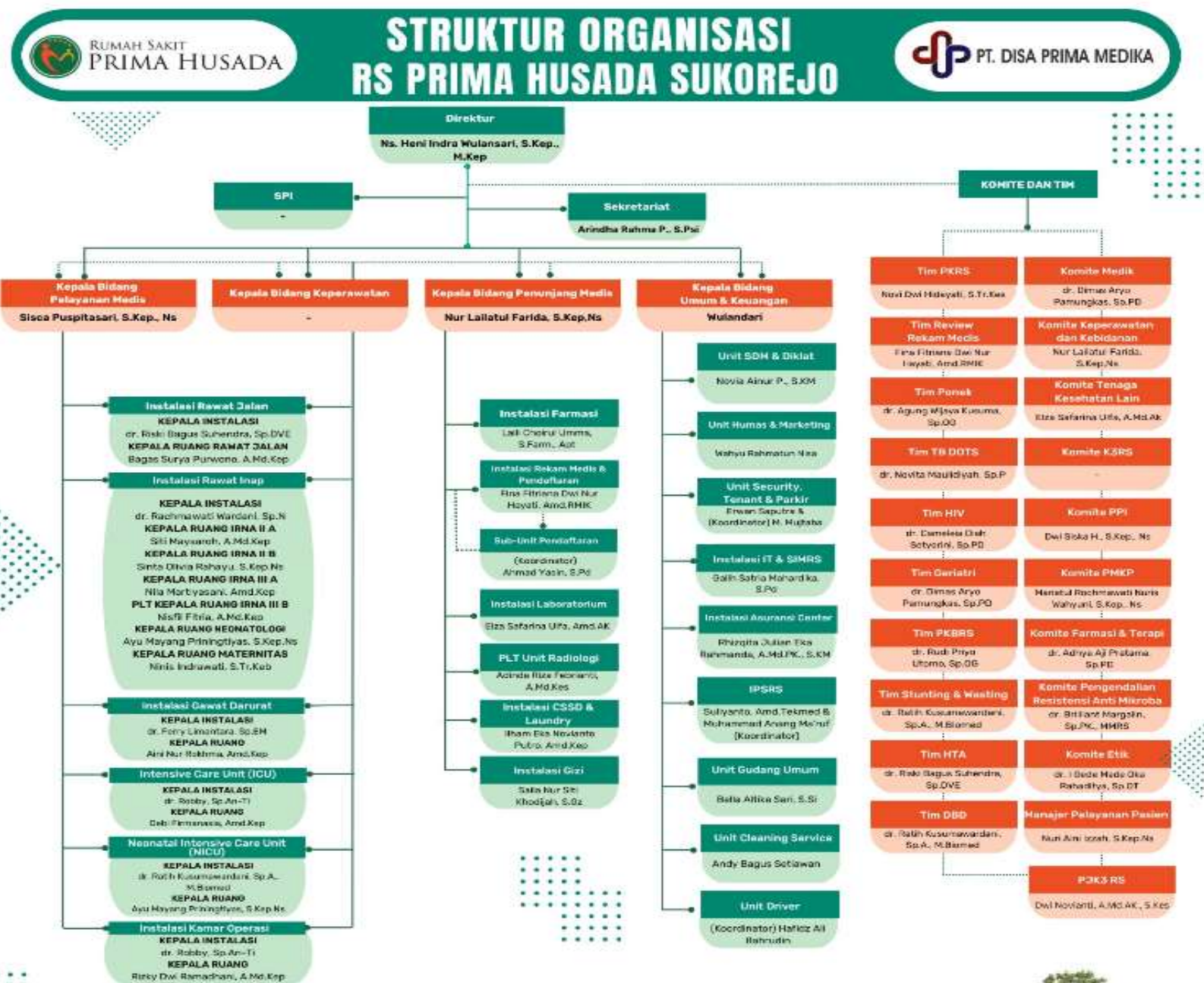
Perjalanan Peningkatan Status Pelayanan:

Tahun 2018	:	Pengajuan ijin Rumah Sakit Prima Husada
27 Desember 2018	:	Ijin operasional keluar.
9 Januari 2019	:	Rumah Sakit Prima Husada diresmikan oleh Bupati Kabupaten Pasuruan.
11 Januari 2019	:	Rumah Sakit Prima Husada menerima pasien serta dilakukan bimbingan akreditasi.
23 April 2019	:	Rumah Sakit Prima Husada sudah melaksanakan Akreditasi Versi SNARS Edisi 1.

BAB III
VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI, DAN TUJUAN

- 3.1 Visi
Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :
“Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”
- 3.2 Misi
Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi:
 - 1. Memberi pelayanan kesehatan dengan amat, tepat, cepat dan akurat
 - 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
 - 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.
- 3.3. Falsafah
Memberikan pelayanan secara profesional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
- 3.4. Landasan 7 Nilai Budi Utama
Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama:
 - 1. Jujur
 - 2. Tanggung Jawab
 - 3. Visioner
 - 4. Disiplin
 - 5. Kerjasama
 - 6. Adil
 - 7. Peduli
- 3.5. Tujuan
Rumah Sakit Prima Husada menjadi Rumah Sakit yang memberikan solusi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya.
- 3.6. Motto
“Sahabat Menuju Sehat”.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT



1. Unit Struktural

a. Direktur Rumah Sakit

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu:

- 1) Kepala Bidang Pelayanan membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit.
 - 2) Kepala Bidang Penunjang membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit.
 - 3) Kepala Bidang Umum membantu Direktur dalam bagian :
 - a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - c) Umum meliputi : Saranan dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tangga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak, dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.
 - d) Sistem Manajemen Rumah Sakit
-

c. Kepala Instalasi dan Kepala Unit

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit. Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian:

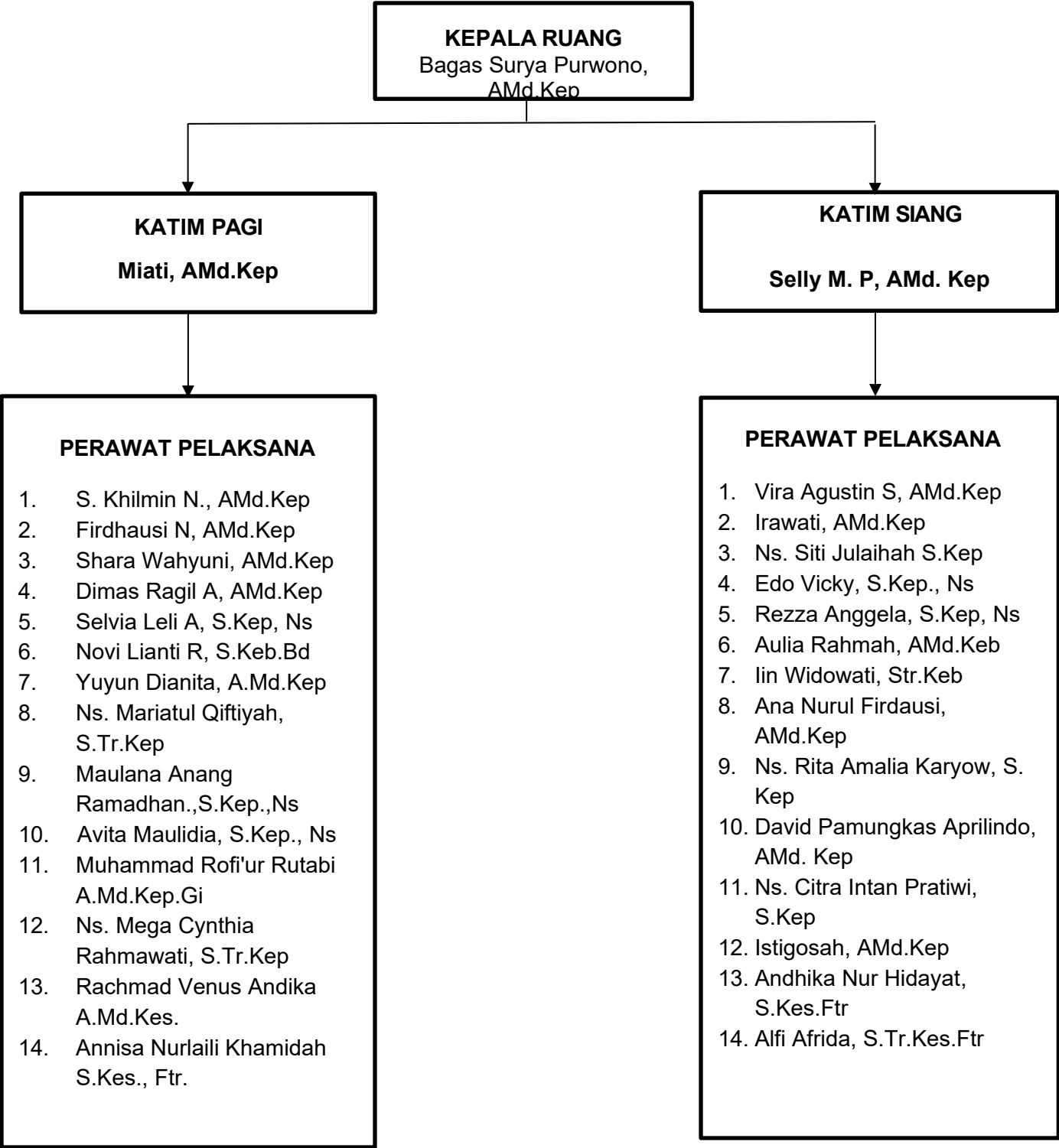
- 1) Kepala Instalasi Rawat Jalan
- 2) Kepala Instalasi Rawat Inap
- 3) Kepala *Intensive Care Unit*
- 4) Kepala Instalasi Gawat Darurat
- 5) Kepala Instalasi Kamar Operasi
- 6) Kepala Instalasi Farmasi
- 7) Kepala Unit Rekam Medis
- 8) Kepala Unit Laboratorium dan BDRS
- 9) Kepala Unit Radiologi
- 10) Kepala Unit Gizi
- 11) Kepala Unit Laundry
- 12) Kepala Unit Sterilisasi
- 13) Kepala Unit Kamar Jenazah
- 14) Kepala Unit SDM
- 15) Kepala Unit Diklat
- 16) Kepala Unit Keuangan dan Akuntansi
- 17) Kepala Unit Hemodialisa
- 18) Kepala Unit Cleaning Service

2. Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/Panitia/Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah sebagai berikut:

- a. Komite Medik
- b. Komite Keperawatan
- c. Komite PPI
- d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- e. Komite K3RS
- f. Tim Rekam Medis
- g. Tim TB DOTS
- h. Tim PONEK
- i. Tim Geriatri
- j. Tim HIV
- k. Tim PKRS
- l. Tim KMKB

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI RAWAT JALAN



BAB VI
URAIAN JABATAN

6.1. Uraian Jabatan
Tabel 1.1 Uraian Jabatan

No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
1.	Kepala Instalasi Rawat Jalan	1. Pendidikan a. Dokter Spesialis Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika b. Spesialis Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika 2. Pengalaman Kerja a. Dokter spesialis Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika Rumah Sakit lebih dari tiga tahun 3. Keterampilan a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 4. Usia a. 30 tahun – 60 tahun 5. Uraian tugas a. Menyusun dan melaksanakan perencanaan program dana anggaran Unit Rawat Jalan terkait SDM, Fasilitas, Pengembangan Pelayanan, Mutu, Keselamatan Pasien, Keselamatan Kerja Unit Instalasi Rawat Jalan b. Menyusun dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. c. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien di Unit Instalasi Rawat Jalan d. Berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Unit Instalasi Rawat Jalan dan melaksanakannya. e. Menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaruan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal – hal terkait di unitnya. f. Merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instalansi lain sesuai kebutuhan unit. g. Menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang di tetapkan oleh rumah sakit. 6. Tanggung Jawab a. Bertanggung jawab Kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada. b. Membantu dalam menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh rumah sakit. c. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab, serta

		wewenang dan hubungan kerja yang jelas. 7. Wewenang - Meneliti, menganalisa dan mengevaluasi data yang masuk. - Menyusun prioritas usulan kebutuhan Unit Instalasi Rawat Jalan sebagai masukan guna penyusunan anggaran. - Membimbing dan memberi pengarahan kepada bawahan. - Memberi saran untuk bahan pertimbangan atasan. - Menandatangani dokumen – dokumen terkait pelayanan Unit Instalasi Rawat Jalan - Menyampaikan usulan kepada atasan.
No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
2.	Kepala Ruangan Unit Rawat Jalan	- Pendidikan - S1 Keperawatan - Sertifikasi - Surat Sumpah Profesi - STR - SIP - BTCLS / ACLS - Pengalaman kerja - Minimal 3 tahun di bidangnya - Keterampilan - Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi - Usia 25 tahun – 50 tahun - Uraian tugas - Membantu menyusun dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran Unit Instalasi rawat jalan terkait SDM, Fasilitas, Pengembangan, Pelayanan, Mutu, Keselamatan Pasien, dan Keselamatan Kerja Unit Instalasi Rawat Jalan - Membantu menyusun dan melaksanakan program dan melaksanakan program orientasi untuk pelaksana. - Membantu menyusun dan melaksanakan program peningkatan mutu dan Keselamatan pasien di Unit Instalasi Rawat Jalan. - Membantu dalam berkoordinasi dengan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menyusun rancang ulang program peningkatan mutu di Unit Instalasi Rawat Jalan dan melaksanakannya. - Membantu menjaga agar proses penyusunan dan pelaksanaan setiap kegiatan di Unit Instalasi Rawat Jalan disesuaikan dan / atau berdasarkan peraturan perundangdan hukum yang berlaku.

		f. Membantu menyusun perencanaan dan memastikan keberadaan dan pembaharuan perijinan bagi staf, fasilitas, dan hal – hal terkait di unit nya. g. Membantu merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan unit atau instansi lain sesuai kebutuhan unit. h. Menyusun rencana kerja sesuai tujuan dan target pelayanan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. i. Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. j. Pengembangan tatalaksana kerja, tugas – tugas dan tanggung jawab. k. Melakukan pembagian tugas di lingkup internal instalasi. l. Bekerjasama dengan bagian terkait yang di berikan kepada pasien. m. Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksana. n. Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan passion dalam menerima pelayanan. o. Memastikan pelayanan pasien sesuai standar prosedur oprasional yang berlaku. p. Memelihara peralatan medis agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. q. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di rumah sakit serta fasilitas yang ada dan cara penggunaannya. r. Menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. s. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. t. Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien sesuai dengan kompetensinya. u. Menciptakan dan memelihara lingkungan yang bersih dan suasana yang baik antar pasien dan keluarganya sehingga tercipta ketenangan. v. Mengikuti pertemuan yang di perlukan baik rutin maupun non rutin. w. Membimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap tenaga perawat pelaksana. x. Melakukan evaluasi kinerja, sumber daya manusia dalam lingkup kerjanya. y. Berperan serta dalam membahas kassus sebagai upaya untuk
--	--	---

		meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. z. Melakukan pengawasan kerja pelaksana di lapangan dengan berdasar pada pedoman pelayanan, panduan, standar prosedur oprasional dan ketentuan – ketentuan lain yang telah ditetapkan. 7. Tanggung Jawab a. Bertanggung jawab kepada Kepala Unit Instalasi Rawat Jalan b. Bertanggung jawab atas pelayanan dan ketenangan keseharian di Unit Instalasi Rawat Jalan 8. Wewenang a. Membantu Kepala Unit Instalasi Rawat Jalan rumah Sakit. b. Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. c. Pengembangan tatalaksana kerja, tugas – tugas, dan tanggung jawab. d. Melakukan pembagian tugas di lingkup internal Unit Instalasi Rawat Jalan. e. Membantu melaksanakan program orientasi untuk karyawan Unit Instalasi Rawat Jalan. f. Melakukan evaluasi kinerja, sumber daya manusia dalam lingkup kerjanya. g. Menyiapkan sarana, prasarana, fasilitas dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. h. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit serta fasilitas yang ada dan cara penggunaanya. i. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. j. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan instansi / bagian lain yang terkait. k. Berperan serta dalam membahas kasus sebagai upaya untuk meningkatkan mutu. l. Pemantauan penempelan label untuk obat yang memiliki kewaspadaan tinggi.
No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan
3.	Kepala Tim Shift Unit Instalasi Rawat Jalan	1. Pendidikan a. D3 Keperawatan 2. Sertifikat a. Surat Sumpah Profesi b. STR c. SIP d. BTCLS / ACLS 3. Pengalaman kerja a. Minimal 2 tahun dibidangnya

		4. Keterampilan a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerakan, dan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 5. Usia a. 23 tahun – 45 tahun 6. Uraian Jabatan a. Mengikuti pelatihan dan seminar b. Membimbing siswa / mahasiswa PKL c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan di Unit Instalasi Rawat Jalan untuk kelancaran pelayanan. e. Melakukan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat secara tepat dan cepat. f. Memberikan asuhan keperawatan yang telah dilakukan. g. Menerima pasien baru sesuai dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan orientasi kepada pasien dan mengirim pasien ke instalasi lain. h. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan anggota tim. i. Melakukan absensi setiap akan melakukan tugas. j. Melakukan tugas jaga pagi dan sore k. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat dan benar. l. Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis administrasinya. m. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya. n. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara pasien, keluarga serta perawat dengan perawat, dan perawat dengan dokter. 7. Tanggung Jawab a. Secara administrasi fungsional bertanggung jawab kepada kepala ruang b. Bertugas melaksanakan asuhan keperawatan kepada penderita di unitnya. 8. Wewenang a. Memberikan masukan kepada Kepala Ruang. b. Sebagai koordinasi pelaksana kegiatan perawatan di bawah tanggung jawabnya.
No	Nama Jabatan	Persyaratan Jabatan

4.	Perawat pelaksana	1. Pendidikan a. S1 Keperawatan b. D3 Keperawatan 2. Sertifikat a. Surat Sumpah Profesi b. STR c. SIP d. BTCLS /ACLS e. Hiperkes 3. Pengalaman kerja a. Minimal 1 tahun di bidangnya 4. Keterampilan a. Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 5. Usia a. 23 tahun – 40 tahun 6. Uraian Tugas a. Mengikuti pelatihan dan seminar. b. Membimbing siswa / mahasiswa PKL. c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. d. Menyiapkan fasilitas dan lingkungan di Unit Instalasi Rawat Jalan untuk kelancaran pelayanan e. Melakukan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat secara cepat dan tepat. f. Memberikan asuhan keperawatan yang telah dilakukan . g. Menerima pasien baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan orientasi kepada pasien dan mengirim penderita ke instalasi lain. h. Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan anggota tim i. Melakukan absensi setiap akan melakukan tugas. j. Melakukan tugas jaga pagi dan sore k. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat dan benar l. Melakukan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tertulis administrasinya. m. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya. n. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara pasien, keluarga serta perawat dan perawat dengan perawat dan perawat dengan dokter. 7. Tanggung Jawab a. Secara administrasi fungsional bertanggung jawab kepada kepala jaga
----	-------------------	---

		b. Bertugas melaksanakan asuhan keperawatan kepada penderita di unitnya. 8. Wewenang a. Memberi masukan kepada Kepala Jaga b. Sebagai Koordinasi pelaksana kegiatan perawatan di bawah tanggung jawabnya.
--	--	--

6.2. Tugas Klinis

Tugas klinis yang di maksud adalah seseorang yang bekerja dibidang manajemen mempunyai uraian tugas jabatan dan uraian tugas fungsional dilengkapi oleh SPK dan RKK.

a. Kepala Instalasi

Tabel 1.2 Uraian Kompetensi Kepala Instalasi

No	Kompetensi
1	Fungsi pergerakan dan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi sebagai upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. b. Pengembangan tatalaksana kerja, tugas – tugas, dan tanggung jawab. c. Menetapkan pembagian pekerjaan, batasan tugas, tanggung jawab, serta wewenang dan hubungan kerja yang jelas. d. Bekerjasama denga bagian terkait yang lain. e. Memimbing dan melakukan fungsi pengawasan terhadap Kepala Ruangan dan pelaksana. f. Menyiapkan sarana, prasrana, fasilita, dan lingkungan kerja yang sesuai untuk kelancaran pelayanan dan memudahkan pasien dalam menerima pelayanan. g. Memastikan pelayanan pasien sesuai Pedoman Praktik Klinik dan standar prosedur oprasional yang berlakku. h. Memelihara peralatan medis agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. i. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan / tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit.dan menjaga aagar seluruh Sumber Daya Manusia di unitnya selalu patuh terhadap peraturan di Rumah Sakit. j. Menjaga fasilitas yang ada, melakukan sosialisasi cara penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi terkait umur pemakaian fasilitas yang ada di unitnya. k. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik dengan sesama karyawan maupun pasien dan keluarganya. l. Menciptakan dan memelihara lingkungan yang bersih dan suasana yang baik antara pasien dan keluarganya sehingga tercipta ketenangan. m. Mengikuti pertemuan berkala yang di adakan secara rutin. n. Menjaga proses control mutu terhadap ikatan kerja sama yang ada. o. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Instalasi Rawat Jalan, antara lain melalui pertemuan ilmiah dan pelatihan.
2	Fungsi pengawasan dan evaluasi a. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia, fasilitas, dan pengembangan pelayanan dalam lingkup kerjanya. b. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program dan anggaran yang telah di buat. c. Melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dan rancang ulang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unitnya. d. Melakukan evaluasi terhadap perijinan bagi diri sendiri, staf di bawahnya, fasilitas yang ada dan hal – hal terkait, sesuai

	peraturan perundangan yang berlaku.
e.	Melakukan evaluasi terhadap mutu dari proses kerja sama dengan unit dari instansi lain.

b. Perawat Klinik I

Perawat klinis I adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan dasar dengan penekanan pada keterampilan teknis keperawatan di bawah bimbingan. Kompetensi perawat klinis I yaitu :

Tabel 1.3 Uraian Kompetensi Perawat Klinik I

No	Kompetensi
1	Melakukan asuhan keperawatan (pengkajian,menetapkan diagnosis keperawatan,menetapkan intervensi dan melaksanakan tindakan keperawatan serta evaluasi) dengan lingkup keterampilan tehnik dasar.
2	Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam asuhan keperawatan.
3	Melakukan komunikasi terapeutik di dalam asuhan keperawatan.
4	Menerapkan caring dalam keperawatan.
5	Menerapkan prinsip keselamatan klien.
6	Menerapkan prinsip Pengendalian dan Pencegahan Infeksi.
7	Melakukan kerjasama tim dalam asuhan keperawatan.
8	Menerapkan prinsip mutu dalam tindakan keperawatan.
9	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien terkait dengan kebutuhan dasar.
10	Mengumpulkan data kuantitatif untuk kegiatan pembuatan laporan kasus klien.
11	Mengumpulkan data riset sebagai anggota tim penelitian.
12	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku,agama, ras dan antar golongan.
13	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
14	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
15	Menunjukkan sikap asertif.
16	Menunjukkan sikap empati.
17	Menunjukkan sikap etik.
18	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
19	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
20	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
21	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggotatim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.
22	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan
23	Dapat melakukan point of care test (tindakan yang dilakukanpada pasien saat tirah baring)
24	Melakukan pemberian produk darah dengan aman
25	Melakukan perawatan luka
26	Memberikan obat dengan aman dan benar
27	Memberikan obat injeksi
28	Memberikan obat injeksi sedasi ringan
29	Melakukan permintaan pemeriksaan penunjang
30	Melakukan assesmen fungsional
31	Melakukan oral gygiene
32	Melakukan bantuan eliminasi BAB/BAK baik di tempat tidur maupun di kamar mandi
33	Melakukan assesmen nutrisi
34	Membantu memberikan makan per-oral pasien sadar

35	Melakukan pemasangan dan pelepasan NGT
36	Memberikan makan melalui NGT
37	Melakukan edukasi nutrisi dasar
38	Melakukan assesmen eliminasi
39	Melakukan kompres buli-buli
40	Memonitoring intake dan output
41	Melakukan pemasangan dan pelepasan kateter
42	Melakukan perawatan kateter dan bladder training
43	Melakukan perawatan kolostomi
44	Melakukan pemasangan dan pelepasan infus
45	Melakukan perawatan luka infus
46	Melakukan manajemen nyeri dasar
47	Melakukan edukasi resiko jatuh dan pemasangan restrain
48	Melakukan pemberian obat topical
49	Melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan tingkat ketergantungan parsial.
50	Melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan tingkat ketergantungan total.
51	Melakukan pemasangan dan pelepasan mayo tube
52	Memberikan terapi elektrolit pekat
53	Melakukan tintrasi obat sesuai advis dokter
54	Mengoperasikan alat-alat medis khusus (Monitor pasien, Shiringepump, Infuspump)

c. Perawat Klinik II

Perawat klinis II adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan holistic pada klien secara mandiri dan mengelola klien / sekelompok klien secara tim serta memperoleh bimbingan untuk penanganan masalah lanjut / kompleks. Kompetensi perawat klinis II yaitu :

Tabel 1.4 Uraian Kompetensi Perawat Klinik II

No	Kompetensi
1.	Melakukan asuhan keperawatan dengan tahapan dan pendekatan proses keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan partial dan total care.
2.	Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
3.	Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien.
4.	Mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien untuk menentukan intervensi keperawatan.
5.	Menetapkan jenis intervensi keperawatan sesuai tingkat ketergantungan klien.
6.	Menerapkan prinsip etik, legal, dan peka budaya dalam pemberian asuhan keperawatan.
7.	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien.
8.	Menerapkan caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien.
9.	Melakukan kajian insiden keselamatan klien dan manajemen risiko klinis.
10.	Melakukan kajian terhadap kejadian dan risiko infeksi pada klien.
11.	Melakukan kerjasama antar tim.
12.	Menerapkan pengendalian mutu dengan satu metoda tertentu sesuai kebijakan rumah sakit setempat.
13.	Mengimplementasikan pengendalian mutu asuhan keperawatan.
14.	Merumuskan kebutuhan belajar klien dan keluarga secara holistic sesuai dengan masalah kesehatan klien.
15.	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga.
16.	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga.

17	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan dan rencana tindak lanjut.
18	Melaksanakan preceptorsip pada tenaga perawat di bawah bimbingannya dan praktikan.
19	Melakukan diskusi refleksi kasus untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan.
20	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan.
21	Membantu pelaksanaan riset keperawatan deskriptif.
22	Melakukan survey keperawatan.
23	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
24	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
25	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
26	Menunjukkan sikap asertif.
27	Menunjukkan sikap empati.
28	Menunjukkan sikap etik.
29	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
30	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
31	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
32	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

d. Perawat Klinik III

Perawat Klinis III adalah jenjang perawat dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan komperhensif pada area spesifik dan mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah dan melaksanakan pembelajaran klinis. Kompetensi perawat klinis III yaitu :

Tabel 1.5 Uraian Kompetensi Perawat Klinik III

No	Kompetensi
1	Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan partial dan total dengan masalah kompleks di area keperawatan spesifik.
2	Menerapkan filosofi dasar keperawatan pada area keperawatan spesifik.
3	Menerapkan penyelesaian dan pengambilan keputusan masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan di unit keperawatan.
4	Menetapkan jenis intervensi keperawatan sesuai tingkat ketergantungan klien pada lingkup area spesifik.
5	Menerapkan prinsip kepemimpinan dalam melaksanakan asuhan keperawatan.
6	Menerapkan konsep pengelolaan asuhan keperawatan pada unit ruang rawat.
7	Menggunakan metode penugasan yang sesuai dalam pengelolaan asuhan keperawatan di unit ruang rawat
8	Menetapkan masalah mutu asuhan keperawatan berdasarkan kajian standar dan kebijakan mutu.
9	Melaksanakan analisis akar masalah (RCA) dan membuat grading risiko terhadap masalah klinis.
10	Mengidentifikasi kebutuhan belajar klien dan keluarga secara holistic sesuai dengan masalah kesehatan klien di area spesifik.
11	Mengidentifikasi dan memilih sumber – sumber yang tersedia untuk edukasi kesehatan pada area spesifik.
12	Melakukan tahapan penyelesaian masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan.

13	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien dan keluarga pada area spesifik.
14	Menerapkan caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien di area spesifik.
15	Menerapkan prinsip kerjasama interdisiplin.
16	Melaksanakan pengendalian mutu asuhan keperawatan di unit.
17	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga pada area spesifik.
18	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga pada area spesifik.
19	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan pada area spesifik dan rencana tindak lanjut.
20	Melaksanakan preceptorship dan mentorship pada area spesifik.
21	Menginterpretasi hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesifik.
22	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesifik.
23	Melakukan riset keperawatan deskriptif analitik dan inferensial.
24	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
25	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
26	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
27	Menunjukkan sikap asertif.
28	Menunjukkan sikap etik.
29	Menunjukkan sikap empati.
30	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
31	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
32	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
33	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

e. Perawat Klinik IV

Perawat klinis IV adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan melakukan asuhan keperawatan pada masalah klien yang kompleks di area spesialistik dengan pendekatan tata kelola klinis secara interdisiplin, multidisiplin, melakukan riset untuk mengembangkan praktek keperawatan serta mengembangkan pembelajaran klinis. Kompetensi perawat klinis IV yaitu :

Tabel 1.6 Uraian Kompetensi Perawat Klinik IV

No	Kompetensi
1	Melakukan pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan tingkat ketergantungan total dengan masalah kompleks di area spesialistik.
2	Menetapkan jenis intervensi keperawatan pada lingkup masalah klien yang kompleks di area spesialistik.
3	Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan keperawatan.
4	Melakukan evaluasi efektifitas metode penugasan yang sesuai dalam pengelolaan asuhan keperawatan di unit.
5	Merumuskan indikator keberhasilan intervensi keperawatan.
6	Menetapkan pengelolaan asuhan klien dengan masalah kompleks pada area spesialistik.
7	Menetapkan upaya perbaikan mutu.
8	Melakukan tahapan penyelesaian masalah etik, legal dalam asuhan keperawatan dalam berbagai lingkup pelayanan keperawatan.
9	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik klien dengan masalah kompleks di area spesialistik.

10	Menerapkan prinsip caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien dengan kasus spesialistik.
11	Melaksanakan risiko klinis menggunakan pendekatan Health care Failure Mode & Effect Analysis atau Analisis Efek & Mode Kegagalan di Pelayanan Kesehatan (HFMEA).
12	Menerapkan prinsip kerjasama secara interdisiplin / interprofesional.
13	Melakukan upaya perbaikan mutu asuhan keperawatan dengan memberdayakan sumber terkait.
14	Melakukan pengendalian mutu asuhan keperawatan di beberapa unit.
15	Menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar klien dan keluarga pada area spesialistik.
16	Melakukan proses edukasi kesehatan pada klien dan keluarga pada area spesialistik.
17	Mengevaluasi ketercapaian edukasi kesehatan pada area spesialistik dan rencana tindak lanjut.
18	Melaksanakan preceptorship dan mentor ship pada area spesialistik.
19	Menganalisis hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesialistik.
20	Menggunakan hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan pada area spesialistik.
21	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
22	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
23	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
24	Menunjukkan sikap asertif.
25	Menunjukkan sikap empati.
26	Menunjukkan sikap etik.
27	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
28	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
29	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
30	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

f. Perawat Klinik V

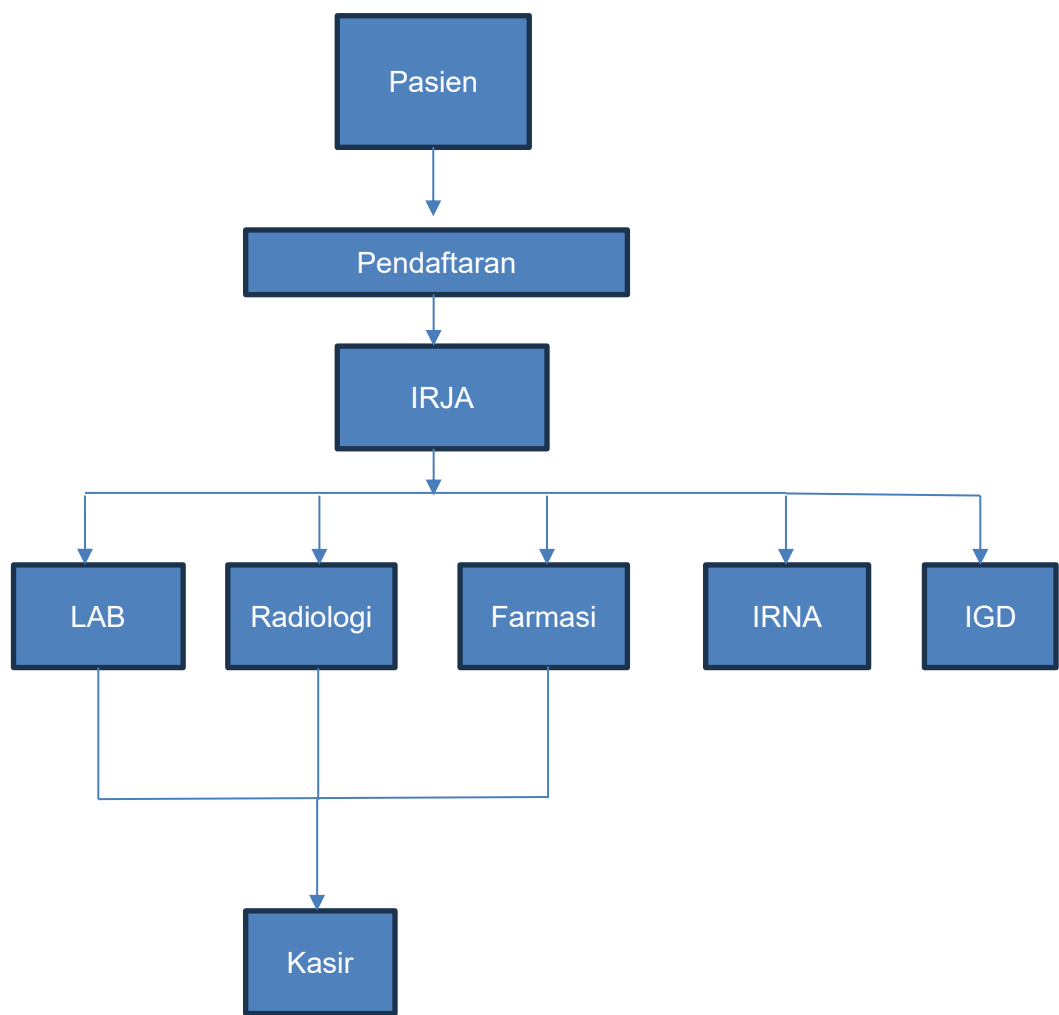
Perawat klinis V adalah jenjang perawat klinis dengan kemampuan memberikan konsultasi klinis keperawatan pada area spesialistik, melakukan tata kelola klinis secara transdisiplin, melakukan riset klinis untuk pengembangan praktik, profesi dan kependidikan keperawatan. Kompetensi perawat klinis V yaitu :

Tabel 1.7 Uraian Kompetensi Perawat Klinik V

No	Kompetensi
1	Menerapkan prinsip caring yang sesuai dengan karakteristik dan masalah klien yang kompleks di area spesialistik.
2	Merumuskan strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis secara lintas disiplin.
3	Menganalisis potensi risiko klinis dari intervensi keperawatan.
4	Menerapkan prinsip dan model kerja sama secara interdisiplin/interprofesional dalam pelayanan kesehatan, transdisiplin.
5	Menerapkan tata kelola klinis dalam pelayanan kesehatan.
6	Mengembangkan metode penugasan berdasarkan bukti ilmiah.
7	Merumuskan indikator kinerja kunci pengelolaan asuhan klien dengan masalah kompleks pada area spesialistik sebagai acuan penilaian.
8	Mengembangkan metoda perbaikan mutu asuhan keperawatan

	berdasarkan bukti ilmiah.
9	Menggunakan filosofi dasar keperawatan sebagai dasar keputusan dalam pemberian asuhan keperawatan spesialistik.
10	Menyediakan pertimbangan klinis sebagai konsultan dalam asuhan keperawatan klien dengan masalah klien yang kompleks di area spesialistik.
11	Melakukan pembinaan tata laku dan pertimbangan etik profesi, legal dalam lingkup pelayanan keperawatan.
12	Menggunakan komunikasi terapeutik yang sesuai dengan karakteristik, masalah klien yang kompleks di area spesialistik sebagai konsultan.
13	Menyusun strategi penanganan akar masalah dan risiko klinis secara lintas disiplin.
14	Menggunakan model kerjasama secara Interdisiplin /interprofesional pelayanan kesehatan, transdisiplin.
15	Melakukan pemberian konsultasi klinis dalam asuhan keperawatan pada klien dengan masalah kompleks pada area spesialistik.
16	Mengembangkan berbagai alternatif intervensi keperawatan berdasarkan bukti ilmiah.
17	Mengembangkan sistem dalam menjaga mutu asuhan keperawatan secara keberlanjutan.
18	Melaksanakan konsultasi dan edukasi kesehatan baik bagi peserta didik, sejawat, klien, maupun mitra profesi sesuai kebutuhan.
19	Menyediakan advokasi sebagai konsultan dalam pelaksanaan preceptorship dan mentorship.
20	Mengevaluasi hasil penelitian untuk merumuskan intervensi keperawatan.
21	Melakukan riset keperawatan semi eksperimental dan eksperimental.
22	Menunjukkan sikap memperlakukan klien tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
23	Menunjukkan sikap pengharapan dan keyakinan terhadap pasien.
24	Menunjukkan hubungan saling percaya dengan klien dan keluarga.
25	Menunjukkan sikap asertif.
26	Menunjukkan sikap empati.
27	Menunjukkan sikap etik.
28	Menunjukkan kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman keperawatan.
29	Menunjukkan tanggung jawab terhadap penerapan asuhan keperawatan sesuai kewenangannya.
30	Menunjukkan sikap kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan klien.
31	Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan.

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA



7.1. POLA HUBUNGAN PELAYANAN

7.1.1. Pola Hubungan dengan Instalasi / Unit Pelayanan Struktural

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Transport pasien antar bagian
2.	Instalasi Kamar Operasi (IKO)	Transport pasien antar bagian
3.	Instalasi Rawat Inap (IRNA)	Transport pasien antar bagian
4.	Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)	1. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 2. Pelayanan resep pasien rawat jalan. 3. Pengecekan <i>box dan trolly emergency</i> .

7.1.2. Pola Hubungan Dengan Instalasi / Unit Penunjang

No.	Unit/Instalasi Terkait	Uraian Hubungan Kerja
1	Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSR)	1. Perbaikan peralatan dan sarana Instalasi Rawat jalan 2. Pengkondisian lingkungan area Instalasi Rawat jalan

2	Unit Pengadaan	1. Pengadaan sediaan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
3	Instalasi Rekam Medik	1. 2. Kelengkapan pengisian rekam medic.
4	Bagian Administrasi	1. Keperluan data dan dokumen.
5	Unit Humas	1. Survei kepuasan Pasien. 2. Standar Pelayanan. 3. Program MCU
6	Tim IT	1. Pengecekan komputer dan perangkatnya. 2. Perbaikan program Billing SIMRS.
7	UMUM	1. Kebersihan ruangan. Persiapan ruangan untuk event.
8	KASIR	2. Pembayaran pelayanan rawat Jalan

BAB VIII
POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI

Dalam upaya mempersiapkan tenaga medis Unit Instalasi Rawat Jalan yang handal perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan dan mempertahankan sumber daya manusia yang tepat. Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan SDM, yaitu proses mengantisipasi dan menyiapkan tenaga dengan kualifikasi sesuai standar. Tujuannya adalah mendaya gunakan sumber – sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan, kualifikasi Pendidikan, sertifikat khusus, pengalaman kerja. Perencanaan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai sasarannya melalui strategi pengembangan konstribusi acuan yang di gunakan menggunakan perhitungan Beban Kerja.

- 8.1. Perhitungan Pola Ketenagaan.
Sesuai dengan Perhitungan Depkes 2005
Jadi kebutuhan staf perawat pelaksana Instalasi Rawat Jalan sebanyak 26 sampai 27 orang perawat.

8.2. Kualifikasi Personil

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Sertifikat Khusus(Diklat yang mendukung)	Pengalaman Kerja
1.	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Dokter Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika	Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika	Dokter spesialis Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika di Rumah Sakit lebih dari tiga tahun
2.	Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan	S1 Keperawatan	- Surat Sumpah Profesi - STR - SIK - ACLS/BTCLS	Minimal 3 tahun dibidangnya
3.	Kepala Jaga Shift	D3 Keperawatan	- Surat Sumpah Profesi - STR - SIK - ACLS/BTCLS	Minimal 2 tahun dibidangnya
4.	Perawat Pelaksana	S1 Keperawatan	- Surat Sumpah Profesi - STR - SIK - ACLS/BTCLS	Minimal 1 tahun dibidangnya

Adapun distribusi ketenagaan sumber daya manusia di Unit Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

JABATAN	JUMLAH SDM			KUALIFIKASI						KET
				PENDIDIKAN			SERTIFIKASI			
	STANDAR	KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	STANDAR	KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	STANDAR	KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	
Ka Instalasi	1	1	0	Dokter	+	-	Mutu dan keselamatan pasien	-	+	
							ACLS	+	+	
							PPI	+	-	1 kali/tahun
							Penanggulanga n bencana	+	+	1 kali/tahun
							Code blue	+	+	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	-	+	
Ka Ruang	1	1	0	Ners	Ners	Ners	Mutu dan keselamatan pasien	+	+	
							PPI	+	+	1 kali/tahun
							Penanggulanga n bencana	+	+	1 kali/tahun
							Code blue	+	+	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	+	+	

Pelaksana PK 2	4	4	0	Ners	Ners + D3	Ners	Mutu dan keselamatan pasien	+	+	
							PPI	+	+	1 kali/tahun
							Penanggulan n bencana	+	+	1 kali/tahun
							Code blue	+	+	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	+	+	
Pelaksana PK 1	5	5	0	Ners	Ners + D3	Ners	Mutu dan keselamatan pasien	-	-	
							PPI	-	-	1 kali/tahun
							Penanggulan n bencana	-	-	1 kali/tahun
							Code blue	-	-	1 kali/tahun
							Komunikasi efektif	-	-	1 kali/tahun

NAMA JABATAN	WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi Rawat jalan	1 shift	1 orang
Kepala ruang Instalasi Rawat Jalan	1 shift	1 orang
Kepala Tim	2 shift	2 orang
Perawat Pelaksana	2 shift	24orang

Pengaturan Jaga di Unit Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

NAMA JABATAN	WAKTUKERJA	DEFINISI WAKTU KERJA	JUMLAH SDM
Kepala Instalasi Rawat jalan	1 shift	08.00-16.00	1 orang
Kepala Unit Instalasi Rawat jalan	1 shift	08.00-16.00	1 orang
Kepala Tim Instalasi Rawat jalan	2 shift	06.30-14.30 14.00-21.00	2 orang
Perawat Pelaksana	7 shift	06.30 - 14.30 08.00 - 16.00 09.00 - 17.00 10.00 - 18.00 11.00 - 19.00 12.00 – 20.00 14.00 – 21.00	24 orang

Seleksi Calon Karyawan

Seleksi calon karyawan adalah aktivitas atau usaha yang di lakukan untuk mengundang para pelamar sebanyak mungkin sehingga Unit Instalasi memiliki kesempatan yang luas untuk menemukan calon yang paling sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan. Seleksi calon karyawandilakukan karena berdasarkan analisa kebutuhan tenaga, ditemukan jumlah pasien dan kegiatan tidak seimbang dengan jumlah tenaga yang ada.

Berdasarkan sumber seleksi calon karyawan dapat di bagi dua yaitu:

1. Dari dalam Rumah Sakit Prima husada sendiri (internal resource)
Menarik calon dari dalam RS Prima Husada sendiri (Internal Resource) memiliki keuntungan lebih yaitu calon sudah di kenal dengan kinerja yang baik dan proses dapat dilakukan dengan lebih cepat di banding menarik calon dari luar RS Prima Husada. Untuk mendapatkan calon pelamar dapat melalui berkas – berkas pelamar yang masuk ke Rumah Sakit Prima Husada.
2. Dari luar RS. Prima Husada (external resources)
Proses penarikan calon dari luar RS Prima Husada ini dapat di lakukan dengan cara iklan media cetak dan kerja sama dengan lembaga pendidikan tentang kebutuhan dengan kualifikasi tertentu.

Kriteria calon karyawan menurut Standar Unit Instalasi Rawat RS Prima Husada :

1. Perawat
 - a. Lulusan S1 Keperawatan.
 - b. Berasal dari Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi B.
 - c. Memiliki IPK minimal 3,00.
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - e. Memiliki pemahaman tentang Pelayanan RS dengan baik.
 - f. Mudah bekerja secara mandiri dan tim.
 - g. Memiliki pengalaman kerj minimal 1 tahun

8.3. Pengembangan SDM

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di Unit Instalasi Rawat Jalan khususnya dan RS

Perawat Unit Instalasi Rawat jalan. Pembinaan / pengembangan di lakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan menambah pengetahuan wawasan bidang pelayanan keperawatan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat di lakukan dengan dua cara yakni

1. Pendidikan

Tenaga dengan pendidikan setingkat D3 di haruskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan S1 Ners.

2. Pelatihan

Pelatihan untuk peningkatan kompetensi perawat Di Unit Instalasi Rawat Jalan, di laksanakan melalui :

- a. *Internal Training* yaitu : program pelatihan yang diselenggarakan oleh RS Prima Husada, yang sudah di laksanakan yaitu pelatihan PPI dasar, dan standar keselamatan pasien, komunikasi efektif, pelatihan apar dan BHD
- b. *External Training* yaitu : program pelatihan di luar rumah sakit yang diikuti sesuai dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya mutu pelayanan Unit Instalasi Rawat Jalan

BAB IX
KEGIATAN ORIENTASI

9.1. Orientasi Tenaga Medis :

HARI KE	MATERI	WAKTU	METODE	PENANGGUNG JAWAB
1	Penjelasan status kepegawaian Penjelasan program orientasi yang akan diterima pegawai, peraturan dan tata tertib masa orientasi Kepada pegawai dikenalkan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Orientasi di unit kerja dimana pegawai ditempatkan Pegawai diberikan berbagai materi orientasi dengan penjadwalan khusus meliputi : 1. Visi, misi, nilai, struktur organisasi 2. Etika bekerja 3. Kesejahteraan spiritual 4. Service excellence 5. Handling complaints 6. <i>Basic life support</i> 7. Penanggulangan bencana kebakaran 8. Patient safety 9. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7 jam	Ceramah dan diskusi	SDM
2	Mempelajari SPO Keperawatan. Mempelajari Pedoman Pelayanan dan Pedoman Organisasi Instalasi Rawat Jalan	2 jam	Ceramah, membaca , dan diskusi	Instalasi Rawat Jalan
3	Mempelajari dan praktek alur pelayanan pasien Instalasi Rawat Jalan. Mempelajari tata cara pelayanan pada pasien Instalasi Rawat Jalan	5 jam	Ceramah, diskusi, dan praktek	Instalasi Rawat Jalan

4	Mempelajari dan praktek alur pelayanan pasien Instalasi Rawat Jalan yg berhubungan dengan unit lain	7 jam	Ceramah,diskusi, dan praktek	Kepala Unit Instalasi Rawat Jalan
---	---	-------	------------------------------	-----------------------------------

BAB X

PERTEMUAN RAPAT

Rapat merupakan suatu pertemuan yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk membicarakan atau memecahkan suatu masalah tertentu. Tujuan sebagai berikut :

1. Dapat membantu terselenggaranya pelayanan keperawatan yang professional di unit Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit prima Husada.
2. Dapat menggali segala pemersalahan terkait dengan pemberian pelayanan di Instalasi Rawat Jalan
3. Dapat memberi jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang terkait dengan pelayanan di unit Instalasi Rawat Jalan

Rapat terdiri dari 2 macam yaitu :

1. Rapat Rutin.
 - a. Rapat Koordinasi antar unit di selenggarakan pada setiap satu bulan sekali minggu pertama di Hall Andalusia. Rapat ini di hadiri oleh Kepala Instalasi, Kepala ruangan, dan Unit – Unit terkait untuk membahas tentang koordinasi antar unit dalam satu RS.
 - b. Rapat Internal Unit Instalasi Rawat Jalan di lakukan setiap satu bulan sekali pada minggu pertama. Rapat ini di hadiri oleh seluruh tim Unit Instalasi Rawat Jalan RSPH untuk membahas pemersalahan internal ataupun eksternal, koordinasi Internal, update keilmuan, dan lain – lain.
2. Rapat insedentil
Rapat Insedentil di selenggarakan sewaktu – waktu bila ada maslah atau sesuatu hal yang perlu di bahasndan sosialisasi kebijakan baru.

BAB XI
PELAPORAN

Berikut data laporan Unit Instalasi Rawat Jalan meliputi :

No	Jenis Laporan	Nama Laporan	Uraian Laporan
1.	Laporan Register Harian	Laporan jumlah pasien harian	Laporan register harian meliputi pelaporan jumlah pasien, jenis pembayaran pasien
2.	Laporan Bulanan	Laporan jadwal dinas tenaga medis	Laporan jadwal dinas unit Instalasi Rawat Jalan disusun oleh kepala unit Instalasi Rawat Jalan yang disetujui oleh kepala bidang pelayanan, kepala SDM dan Direktur
		Laporan bulanan unit	Laporan bulanan unit disusun oleh kepala ruang Instalasi Rawat Jalan yang melaporkan kebutuhan jumlah SDM, fasilitas, pengembangan pelayanan, kinerja produktivitas, mutu, evaluasi jadwal kegiatan, serta kritik dan saran dalam rangka perbaikan unit Instalasi Rawat Jalan
3.	Laporan Tahunan/ semester	Laporan evaluasi kinerja individu	Laporan evaluasi kinerja individu dilakukan oleh kepala unit Instalasi Rawat Jalan untuk mengevaluasi kinerja perawat pelaksana. Evaluasi kinerja juga dilakukan pada tenaga perawat pelaksana yang dilakukan oleh kepala unit Instalasi Rawat Jalan. Hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan kinerja karyawan dan melakukan perbaikan apabila terdapat yang tidak sesuai dengan Standar yang ditetapkan.

BAB XII PENUTUP

Pedoman Pengorganisasian unit Instalasi Rawat Jalan disusun dalam rangka memberikan acuan bagi Rumah Sakit yang telah maupun akan menyelenggarakan pelayanan unit Instalasi Rawat Jalan yang bermutu, aman, efektif dengan mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu setiap rumah sakit diharapkan dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman ini dan dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01
September 2025
Direktur Rumah Sakit Prima
Husada,



**Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,
M.Kep**